

INFORME DE EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

— Variante Profesional —

PACIENTE

Carmen Rosa Velásquez Ortiz

DOCUMENTO

CC 20123456

FECHA NACIMIENTO

22/07/1952

EDAD

74 años, 5 meses

SEXO

Femenino

ESCOLARIDAD

Primaria Incompleta

LATERALIDAD

Diestra

FECHA DE EVALUACIÓN

11/01/2027

ORDEN N°

—

PROTOCOLO APLICADO

bateria_emergencia_am

ELABORADO POR

Profesional admin-read

Psicólogo

INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

Nombre:	Carmen Rosa Velásquez Ortiz	Lateralidad:	Diestra
Documento:	CC 20123456	Ocupación:	Pensionada (ex-docente)
Fecha de nacimiento:	22/07/1952	Ciudad:	Cali
Edad:	74 años, 5 meses	Acompañante:	Hija María Velásquez
Sexo:	Femenino	Remite:	Hija (familia)
Escolaridad:	Primaria Incompleta	EPS / Asegurador:	Nueva EPS

MOTIVO DE CONSULTA

Hija refiere cuadro de 6 meses: tristeza persistente, aislamiento, pérdida de interés, llanto frecuente, y EXPRESA IDEA DE QUERER 'DESCANSAR'. Dormitorio desordenado con medicamentos acumulados.

PRUEBAS APLICADAS

Protocolo: bateria_emergencia_am

Prueba	Dominio	Dur.
Escala de Depresión Geriátrica Yesavag	Socioemocional - Depresión	—
Span Retención Dígitos Directo	Memoria de Trabajo	—
Span Retención Dígitos Inverso	Memoria de Trabajo	—
TMT A	Atención	—
Grober RL Ensayo 1 (libre)	General	—
Grober RLT - Retención Libre Total (E1)	General	—
Grober RT - Recuerdo Total Claves (E1+)	General	—
Fluidez Verbal Animales	Lenguaje - Fluidez	—
Escala de Lawton y Brody (IADL)	General	—

ANTECEDENTES

Patológicos / Médicos

Sin antecedentes médicos de relevancia.

Sin antecedentes psiquiátricos previos.

Farmacológicos

Sin medicación actual.

Niega TEC previo.

Familiares

Sin antecedentes neuropsiquiátricos de primer grado.

OBSERVACIÓN CLÍNICA

Hallazgos cualitativos durante la administración

Apariencia y conducta

Evaluación neuropsicológica. Paciente colaborador.

Atención y concentración

Atención fluctuante, hipoprosexia, se desconecta durante la entrevista. Refiere dificultad para concentrarse ('la cabeza no me da').

Memoria

Quejas subjetivas de memoria. Olvida citas y nombres. Familiares confirman deterioro en los últimos 6 meses. Grober Buschke con deterioro en recuerdo libre (2/16) con mejoría en reconocimiento (8/16) — perfil subcortical-frontal.

Praxias y gnosias

Sin alteraciones significativas en praxias ni gnosias.

Lenguaje

Lenguaje hipofluente, latencias aumentadas, voz (baja). Responde con monosílabos. Denominación conservada (animales: 6).

Funciones ejecutivas

Rigidez cognitiva. Dificultad para alternar categorías en fluencia. Bradipsiquia marcada en TMT-A (245 segundos, escalar 6).

Emociones y comportamiento

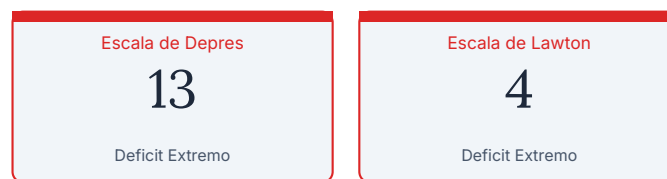
ACTITUD DEPRESIVA PROFUNDA. Llanto durante la entrevista. Expresa: 'ya no quiero seguir así'. Ideación suicida ACTIVA con plan pasivo (acumular medicación). C-SSRS: IDEACIÓN + PLAN + INTENCIÓN = RIESGO ALTO.

Cociente intelectual (observación)

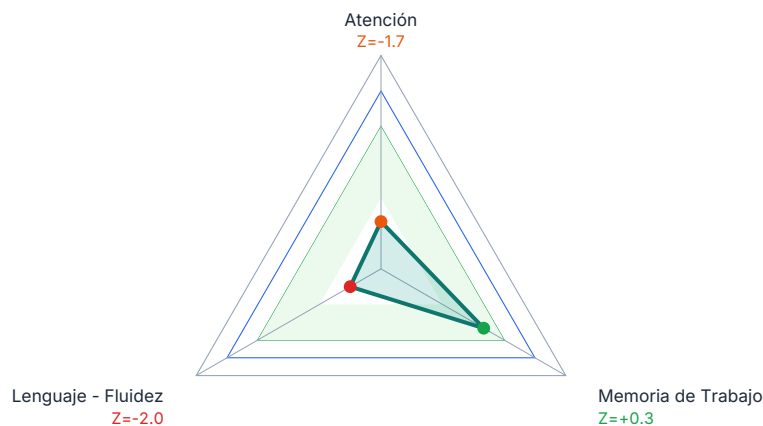
Perfil cognitivo: F32.1 - Episodio depresivo moderado + RIESGO SUICIDA ALTO

RESULTADOS CUANTITATIVOS

Puntajes estandarizados y perfil cognitivo

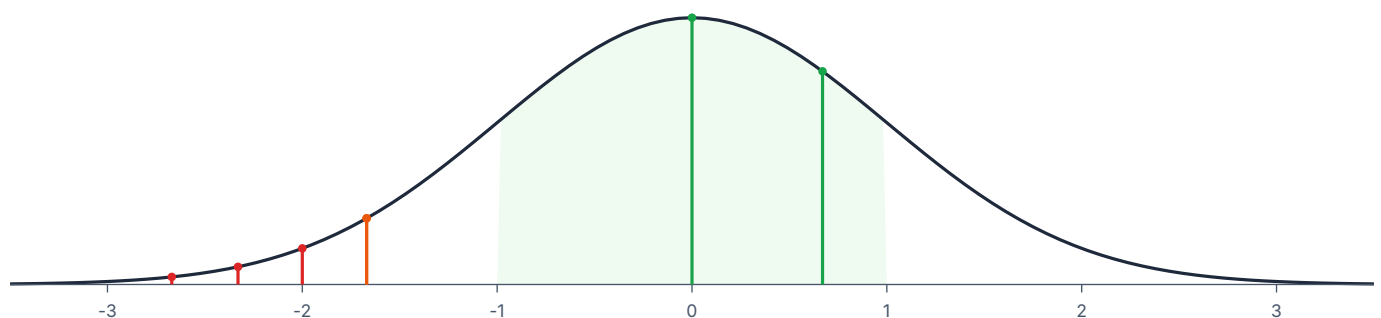


Perfil cognitivo por dominio



Distribución del rendimiento (Z) del paciente sobre la curva normal estándar

n = 7 pruebas con norma disponible



Perfil Z por prueba

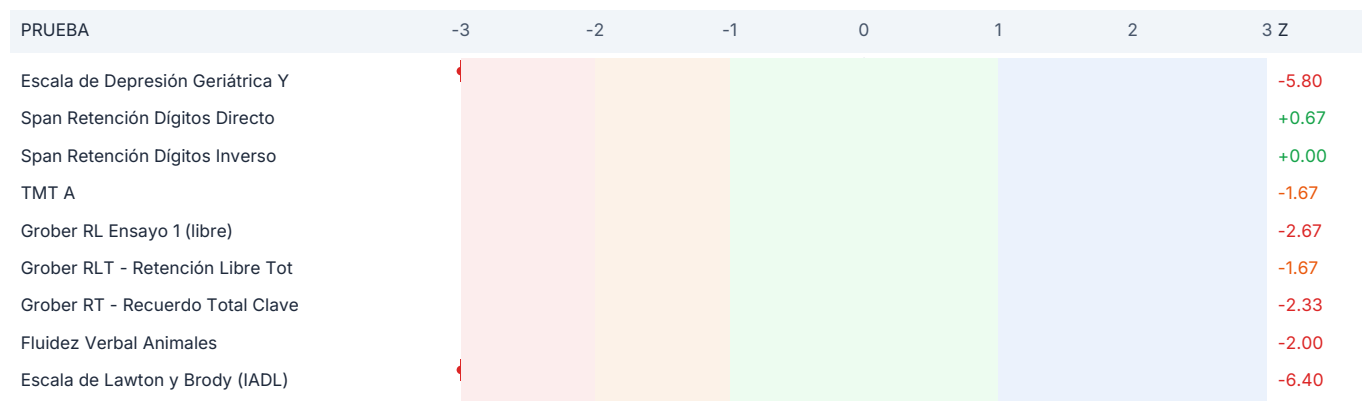


Tabla detallada de puntajes

Prueba	PD	Escalar/CI	Z	Interpretación
Escala de Depresión Geriátrica Yes	13	13	-5.80	Deficit Extremo
Span Retención Dígitos Directo	5	12	+0.67	Promedio
Span Retención Dígitos Inverso	3	10	+0.00	Promedio
TMT A	247	5	-1.67	Límitrofe
Grober RL Ensayo 1 (libre)	3	2	-2.67	Bajo
Grober RLT - Retención Libre Total	3	5	-1.67	Límitrofe
Grober RT - Recuerdo Total Claves	6	3	-2.33	Bajo
Fluidez Verbal Animales	7	4	-2.00	Bajo
Escala de Lawton y Brody (IADL)	4	4	-6.40	Deficit Extremo

SÍNTESIS CLÍNICA INTEGRADORA

Lectura cuantitativa de los hallazgos

El perfil neuropsicológico evidencia debilidades en: general (severamente disminuido, $Z=-2.2$); lenguaje - fluidez (severamente disminuido, $Z=-2.0$); atención (moderadamente disminuido, $Z=-1.7$).

Entre las pruebas con mayor desviación se encuentran Grober RL Ensayo 1 (libre) ($Z=-2.67$, bajo); Grober RT - Recuerdo Total Claves ($E1+E2+E3$) ($Z=-2.33$, bajo); Fluidez Verbal Animales ($Z=-2.00$, bajo). Estos hallazgos orientan la formulación diagnóstica y la priorización de objetivos de intervención.

Áreas con desempeño disminuido

- Grober RL Ensayo 1 (libre) — bajo ($Z=-2.67$)
- Grober RT - Recuerdo Total Claves ($E1+E2+E3$) — bajo ($Z=-2.33$)
- Fluidez Verbal Animales — bajo ($Z=-2.00$)
- Grober RLT - Retención Libre Total ($E1+E2+E3$) — límitrofe ($Z=-1.67$)
- TMT A — límitrofe ($Z=-1.67$)

RESUMEN PARA LA FAMILIA

Lenguaje sencillo para padres, cuidadores y paciente

Saludo

Este es un resumen de la evaluación que se realizó Carmen. Está escrito en un lenguaje sencillo para que sea fácil de entender. Tu psicólogo o psicóloga te explicará los detalles y resolverá cualquier duda que tengas.

¿Qué hicimos en la evaluación?

Realizamos varias pruebas que miden cómo funciona tu cerebro en distintas situaciones: memoria, atención, lenguaje, razonamiento y la velocidad con la que procesas información. Las pruebas son como "pequeños retos" que se resuelven con papel, lápiz y a veces con cubos o figuras. No hay respuestas buenas ni malas: lo que nos interesa es conocer cómo trabaja tu mente.

¿Qué encontramos?

Las áreas donde te fue bien incluyen: En ViRDD, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. En ViRDInv, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. Las áreas donde se recomienda trabajar incluyen: En ViGroberRLT, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo. En ViGroberMC_Tot, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo. En ViAni, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo.

Áreas para apoyar (en qué trabajar)

- En ViRDD, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En ViRDInv, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En ViGroberRLT, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo.
- En ViGroberMC_Tot, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo.
- En ViAni, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo.

¿Qué recomendamos?

Recomendación: URGENTE: Activar protocolo de seguridad. No dejar sola a la paciente. Contactar a hija María (acudiente) para acompañamiento 24/7. (consulta con tu psicólogo/a para detalles específicos). Sobre la consulta médica: si tu psicólogo/a lo sugiere, agenda una cita con psiquiatría para discutir opciones de tratamiento. Sobre la terapia: continúa con tus sesiones según lo acordado. Si tienes dudas, coméntalas con tu terapeuta. Sobre la consulta médica: si tu psicólogo/a lo sugiere, agenda una cita con psiquiatría para discutir opciones de tratamiento.

Preguntas frecuentes

- ¿Mis resultados son permanentes?
No necesariamente. El cerebro puede cambiar con el tiempo, especialmente con práctica y los apoyos adecuados. Los resultados que obtuviste son una foto del momento actual.
- ¿Por qué algunos resultados son mejores que otros?
Es completamente normal. Todas las personas tienen áreas donde son más fuertes y áreas donde pueden mejorar. Esto no significa que haya algo mal en ti.
- ¿Necesito otro tipo de evaluaciones?
Tu psicólogo/a te dirá si se necesitan otros estudios (por ejemplo, evaluación pedagógica, médica, o del lenguaje). No te preocupes si no entiendes algún término: puedes preguntar siempre.

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

DSM-5 / CIE-10

Diagnóstico codificado

Código CIE-10: F32

Impresión diagnóstica: F32.1 - Episodio depresivo moderado + RIESGO SUICIDA ALTO